ASPECTS COMMUNICATIONNELS DE LA RENCONTRE AVEC LE MALADE ET SA FAMILLE

Pr. EH. ADJA

I. INTRODUCTION

1. La psychologie médicale?

Étudie les aspects psychiques mis en jeu lors des relations entre un patient et un malade,
Elle permet de ne pas limité cette relation aux domaines technique ou organique,
Le médicament le plus fréquemment utilisé en médecine générale est le médecin lui-même (M. Balint),
Une relation médecin-malade de qualité a en elle-même des vertus thérapeutique

2. La médecine moderne se différencie de la médecine traditionnelle:

- **les progrès techniques et scientifiques ont rendu la médecine actuelle plus performante,**
- **Ensuite, les impératifs économiques (déshumanisation),**
- **Enfin, les patients souhaitent être de plus en plus informés et acteurs de leur prise en charge.**

3. La communication médicale a ainsi évolué. D'une part, les médecins ne peuvent aujourd'hui plus se contenter d'être seulement des experts scientifiques. Ils se doivent d'avoir aussi un minimum de compétences en communication auprès des patients et de leur famille.
D'autre part, parce que la communication est toujours une interaction entre deux protagonistes au minimum, les patients doivent également être préparés à communiquer le plus efficacement possible avec les professionnels de la santé.

II. COMMUNICATION AVEC LES SOIGNANTS ET LES FAMILLES

- on ne peut pas ne pas communiquer. Communiquer : c'est être en relation, c'est mettre en commun.
- la communication est définie et étudiée comme « un processus social permanent [Bateson, et de Watzlawick]
- les prises en charge sont à chaque fois remarquables. En effet, malgré la rigueur des protocoles médicaux, les équipes, autant médicales que paramédicales doivent s'adapter, non seulement, à la singularité du patient, à son environnement familial, mais aussi aux interrelations des personnels soignants.

ASPECTS COMMUNICATIONNELS DE LA RENCONTRE AVEC LE MALADE ET SA FAMILLE

Pr. EH. ADJA

A. La communication dans l'équipe

o Crew Ressource Management / Medical Team Training.

- Cet outil se conçoit comme une façon d'être, de communiquer, d'écouter, pour optimiser les savoirs faire de chacun des membres d'un équipage. Le but est d'obtenir une synergie. Ainsi sans l'approche CRM, les qualités individuelles s'additionnent (1+1=2) et avec l'approche CRM, les qualités individuelles se démultiplient (1+1=3).

- La Haute Autorité de Santé (HAS) met en place en 2012 le Medical Team Training (MTT) dans les blocs opératoires afin d'améliorer la synergie des équipes et d'abaisser la mortalité postopératoire.

o Programme d'amélioration continue du travail en équipe (PACTE).

- le projet PACTE dont le but est de réduire à un niveau acceptable les risques d'EIAS.
- Son enjeu principal est la sécurité des patients, ses enjeux secondaires sont d'améliorer la qualité de vie au travail et de renforcer le développement professionnel continu.
- Ses objectifs sont de définir une équipe efficace, de formaliser les méthodes et outils, de définir la participation du patient et ses modalités, d'évaluer l'efficacité d'une équipe afin de fournir un guide pédagogique et un dispositif d'évaluation d'une équipe.
- il s'attache à faire prendre conscience du facteur humain et rendre l'équipe plus efficace. Ses domaines d'action sont : la communication, le leadership, la culture sécurité, la gestion des compétences, les briefings, débriefings, etc.

Équipe ! Comment faire ?

Pour être une équipe, il faut au minimum être deux, avec chacun un rôle défini, des compétences spécifiques, être complémentaire, coopérer, s'entraider et prendre des décisions pour atteindre un objectif commun.

Les équipes soignantes sont habituellement organisées hiérarchiquement. Elles sont le plus souvent multidisciplinaires (différents métiers) parfois interdisciplinaires (différentes spécialités).

Les caractéristiques d'une équipe efficace dépendent non seulement de sa structure organisationnelle (ressources suffisantes, compétences, rôles distincts, taches précises, objectifs clairs, leadership convenable), d'une contribution individuelle (engagement, souplesse, confiance) mais aussi de son processus dynamique (coordination, cohésion, communication, prise de décisions).

La communication est un des piliers nécessaire pour initier et entretenir ce processus d'équipe. « L'enjeu est de passer d'une équipe d'expert à un équipe experte ».

Le cadre conceptuel de Salas établit cinq éléments de base de l'efficacité du travail d'équipe :

- leadership,
- orientation collective,
- surveillance réciproque du rendement,
- comportement de soutien
- et adaptabilité.

L'interaction entre ces cinq éléments laisse entendre que:

(1) le leadership influe directement sur l'orientation collective, la surveillance du rendement et le comportement de soutien;

(2) l'orientation collective et le comportement de soutien influent sur la surveillance du rendement;

(3) la surveillance du rendement et le comportement de soutien engendrent l'adaptabilité.

Ces rapports sont favorisés par trois mécanismes de coordinations, les modèles mentaux communs, la communication en boucle fermée et la confiance mutuelle.

a) **Langage commun**

- Parler peu, mais parler bien, permet d'optimiser la communication.
- L'utilisation d'un langage commun, compris et utilisé par tous les acteurs de soin assure la cohérence, l'exhaustivité et la qualité de la communication.
- Déjà très spécialisé dans notre monde médical et souvent réduit à des abréviations : TC, TS, PA …, notre langage médical peut être confondu en interdisciplinaire.
- Par exemple TS veut dire, tentative de suicide ou temps de saignement ? SAP ou SE, seringue auto pulsée ou électrique ? EMG, équipe mobile de gériatrie ou électromyogramme ?

Dans le même cadre, il a été démontré qu'un langage trop familier pouvait nuire à la prise en charge des patients.

b) Communication en boucle fermée

L'expéditeur énonce l'information; le destinataire confirme que l'information a été entendue et en répète le contenu, enfin l'expéditeur confirme que l'information reçue a été la bonne ou corrige celle-ci.

Par exemple, le médecin dit « Préparez de la noradrénaline… », l'infirmier répond « je prépare de la noradrénaline à 0,5mg/ml. », le médecin confirme « OK ».

Ce type de communication structurée améliore la fiabilité de la communication.

B. COMMUNICATION AVEC LES PROCHES

Si, se parler entre membres d'une équipe est indispensable à la bonne marche d'un service, parler au patient et à sa famille est imposé par la loi.

En effet, le cadre de diffusion d'une information au patient et à sa famille, est légiféré : non seulement toute personne doit être informée sur son état de santé, mais l'information donnée se doit d'être claire, loyale et appropriée.

Le médecin doit s'assurer que l'information a été comprise.

La famille s'inscrit dans une continuité du patient instaurant une globalité de prise en charge.

La personnalité du patient, mais aussi sa bonne compréhension, ainsi que celle de sa famille, doivent être prises en compte dans la démarche d'annonce.

Aller à la rencontre d'une famille est, à chaque fois, une prise de risque pour le soignant

- Il est difficile aujourd'hui de donner une définition exacte de la famille ; elle peut être nucléaire (père/mère/enfants), élargie (grands parents, cousins, oncles…)
- Par exemple, un patient de 80 ans admis dans un état grave au-delà de toutes ressources thérapeutiques, peut-être pour sa famille, un patriarche, être celui qui cimente les liens familiaux ou à l'inverse être le vieux monsieur placé en maison de retraite et que l'on voit une fois par an. Son hospitalisation brutale peut entrainer une perte de repères et de places pour chacun de ses membres.
- Aller à la rencontre d'une famille, c'est tenir compte de ces processus relationnels dynamiques si particuliers à chaque famille.
- La réponse des familles : le stress, l'angoisse, l'impuissance, mais aussi les ressentis de culpabilité ou d'indifférence sont autant de réactions qui régissent et impactent la communication.

C'est à la croisée de ces différents systèmes et processus dynamiques que le soignant rencontre la famille et doit s'adapter pour communiquer efficacement. Il nous faudra acquérir un savoir-être, savoir dire, et savoir-faire.

a. Communication verbale et analogique

La communication non verbale exprime à notre insu nos émotions et nos sentiments. Si le rire et les pleurs sont les manifestations verbales les plus universelles, reste que leurs expressions sont interprétées en fonction du contexte socio culturel.

- Ainsi, notre façon d'occuper l'espace et de se positionner lors d'une conversation, est un indicateur émotionnel. Par exemple, la distance, dans un entretien, que l'on va mettre avec notre interlocuteur, illustre le lien à l'autre et est significative du respect, de l'intimité, de la tristesse voire de l'agressivité... Si certaines familles sont plus

tactiles que d'autres et recherchent le contact physique, d'autres, au contraire, se sentiraient agressées.

Les soignants doivent s'adapter à ce mode corporel relationnel spécifique.

b. <u>Savoir-être</u>

- Dire, c'est surtout montrer, et particulièrement dans un contexte d'urgence, où le facteur stress a un impact non négligeable. En effet, les réactions émotionnelles soumises au stress, peuvent être adaptées, mais aussi parfois être de fortes intensités submergeant voire inhibant toutes cognitions.
- Les processus communicationnels, afin d'être efficients, nécessitent une congruence entre les messages verbaux et non verbaux. Ainsi, si le langage digital compte, via les mots lors d'une rencontre, le langage analogique, via le corporel, est décisif lors des entretiens.

c. <u>Savoir dire,</u>

- Rencontrer une famille pour annoncer l'état somatique de leur proche s'anticipe. Le médecin annonciateur doit se préparer à son entretien. Avant même la rencontre, tel un pilote, il doit faire une « check list » des informations ciblées sur le patient afin d'être au clair sur quoi dire.
- Ainsi, sans même avoir parlé, des informations ont déjà été transmises par chaque acteur des systèmes présents. Par exemple, ne pas regarder les proches dans les yeux, rester debout si les proches sont assis, croiser les bras, renseigner dans un couloir, accrocher naturellement notre regard à celui qui fait le plus de bruit ou qui prend le plus de place ; sont des erreurs classiques.

d. <u>Savoir-faire</u>

- Le respect, la chaleur et l'humanité sont les vecteurs de l'alliance aux proches.
- Le savoir-être auprès des familles en souffrance passe en premier lieu par la reconnaissance de cette souffrance, en offrant un cadre et une écoute adaptés, pour la recevoir et ainsi permettre à la famille de vivre les émotions qui l'habitent.
- Bien communiquer aux équipes en employant un langage commun s'applique à la communication aux proches. La rencontre des systèmes croisés, médecin/équipe/patient/famille, impose de ne pas se retrancher derrière des techniques médicales et un vocabulaire scientifique.

III. CONCLUSION

- Dire, faire, et transmettre pour un soignant nécessite un apprentissage pour se sentir en sécurité d'agir.
- une communication claire et circoncise, dans un temps donné, entre les interlocuteurs d'une équipe met en exergue une structuration des échanges afin d'offrir une meilleure efficience.
- L'entretien avec les proches, nécessite de prendre son temps, de se montrer disponible et bienveillant.
- Dire, c'est savoir être pour savoir-faire. La communication aux urgences et dans l'urgence, par exemple est aussi technique qu'un soin médical. C'est un soin relationnel qui influe sur la sécurité et le devenir du patient.

Résumé :

1. Une mauvaise communication entre les membres d'une équipe soignante peut être la cause directe d'évènements indésirables graves liés aux soins.
2. Une communication efficace améliore la sécurité des patients.
3. La communication dans l'équipe et auprès des proches s'apprend et doit être structurée.
4. Deux modes de communication sont à intégrer : le verbal et le non verbal.
5. Des outils comme les check-lists, un langage commun et concis, une écoute active, la reformulation… facilitent la communication.
6. La communication permet de passer d'une équipe d'experts à une équipe experte.
7. Dans le contexte d'urgence, la communication doit être orchestrée, rythmée par un chef d'équipe ou team leader.
8. L'information au patient et aux proches est imposée par la loi.
9. Communiquer aux proches aux urgences et dans l'urgence, c'est paradoxalement prendre son temps, car il n'y a pas d'urgence à dire afin de bien dire.

BIBLIOGRAPHIES

1. Communication avec les soignants et les familles. Delphine Garrigue Huet1,2, Christelle Rosenstrauch1 , Dominique Carlier1 [1 Pôle de l'Urgence, CHU Lille, F-59000, Lille, France 2 Pôle d'Anesthésie réanimation, CHU Lille, F-59000, Lille, France]

2. Bateson G. Communication et société. Seuil ; 1988.

3. Watzlawick P. Une logique de communication. Seuil ; 1967

4. Haute Autorité de Santé. Programme d'amélioration continue du travail en équipe. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1601164/fr/pacte-programme-d-ameliorationcontinue-du-travail-en-equipe